

## [文献研究]

中医特色护理在幽门螺杆菌感染防治中的  
创新应用与进展覃海平<sup>1</sup> 时宗泽<sup>2</sup>

**[摘要]** 幽门螺杆菌(helicobacter pylori, Hp)感染是全球性的公共卫生问题,与多种胃部疾病密切相关。中医特色护理在 Hp 感染防治中展现出独特的优势和潜力,本文旨在综述其在该领域的创新应用与进展。通过分析中医理论与现代医学研究的结合,总结相关研究成果,为中医特色护理在 Hp 感染防治领域的进一步发展提供参考,同时对未来研究方向提出展望,以期推动中医特色护理在该领域的广泛应用和创新发展。

**[关键词]** 中医特色护理;幽门螺杆菌;感染防治;创新应用;进展

幽门螺杆菌(helicobacter pylori, Hp)是一种定植于人体胃部的螺旋形革兰氏阴性菌,可通过口—口、粪—口及胃—口等多种途径传播,人群普遍易感,感染率较高<sup>[1]</sup>。2012—2022 年中国流行病学的 Meta 分析数据显示,我国 Hp 综合感染率为 42.11%<sup>[2]</sup>,且家族性 Hp 感染率较高,总体家庭感染率达 71.2%,个体感染率为 40.7%<sup>[3]</sup>。Hp 感染是胃炎、消化性溃疡、胃癌等消化系统疾病的重要致病因素<sup>[4]</sup>,作为危害人类健康的典型致病菌之一, Hp 早在 1994 年就被世界卫生组织列为胃癌 I 类致癌原<sup>[5]</sup>。

感染 Hp 后易导致免疫功能紊乱,出现腹痛、反酸、食欲不振、消化不良、口臭等症状,严重降低患者的生活质量。目前,我国 Hp 感染与胃癌仍呈双重高发态势,且二者关系密切、危害叠加,因此尽早根除 Hp,对预防和控制胃部疾病具有重要的促进作用<sup>[6-7]</sup>。

近年来,中医药因副作用少、效果好,逐渐应用于 Hp 感染治疗;中医特色护理也同步应用于此类患者的临床干预,对改善患者的临床症状具有积极作用。目前已有不少关于中医特色护理在 Hp 感染治疗中的原始研究,常用中医适宜技术包括穴位贴敷、耳穴贴压、辨证施膳及情志护理等<sup>[8-10]</sup>;唐春华等<sup>[11]</sup>对 Hp 感染患者的健康教育进行了总结,为临床护理实践提供了重要参考。基于上述研究,本研究将聚焦中医特色护理在 Hp 感染防治中的创新应用与进展,通过系统综述相关研究成果,总结现有经验,为中医特色护理在该领域的进一步发展提供参考。同时,结合当前研究现状,

对未来研究方向提出展望,旨在推动中医特色护理在 Hp 感染防治中的广泛应用与创新发展。

## 1 中医特色护理防治 Hp 的理论依据

**1.1 中医对 Hp 感染的认识** 中医古典医籍中虽无“Hp”的病名,但从临床症状表现, Hp 感染相关性胃病属中医学“胃脘痛”“嘈杂”“痞满”“泛酸”等病症的范畴<sup>[12]</sup>。多项研究指出, Hp 感染与“湿热”关系密切,认为其发病外因是外邪,内因是脾胃正气亏损<sup>[13-15]</sup>;另有中医学者将 Hp 归为中医“虫证”范畴中的“无形之虫”,认为其病机为脾胃外感、湿热生虫<sup>[16]</sup>。目前多数中医学者将 Hp 归属于“邪气入侵”范畴:“邪气”经口而入,直中脏腑,最终引发疾病<sup>[17-18]</sup>。外邪入侵的常见诱因包括:现代人饮食习惯偏向油腻、辛辣、生冷,易损伤脾胃功能,导致湿热内生,为 Hp 提供“生长土壤”。脾胃虚弱也是 Hp 感染的重要内因:脾为后天之本,主运化水谷精微,若脾胃功能受损,则水谷精微运化失常,易致湿热内生。同时,长期饮食不规律、暴饮暴食等不良饮食习惯会加重脾胃负担,进一步加剧湿热之邪滋生。

**1.2 中医特色护理的理论依据** 中医特色护理以整体观念和辨证施护为特色,通过独特的中医护理技术发挥干预作用。常用的中医护理技术有灸法、穴位按摩、拔罐、刮痧、耳穴贴压等<sup>[19]</sup>。

## 2 中医特色护理在 Hp 感染中的应用

**2.1 穴位贴敷的应用及效果** 穴位贴敷是将药物贴敷于特定穴位,通过刺激经络,调节脏腑功能的中医外治法。该疗法可以避免口服给药及个体耐受性差异导致的肝脏和肾脏功能损伤,具有不良反应少、安全性高、经济实用、操作简便、疗效确切等特点。刘萍等<sup>[20]</sup>选取丁香、茯苓、莲子、炒山楂、山药等药物磨成药末,用新鲜姜汁调制成药糊,贴敷于 Hp 感染患者的中脘穴、关元穴、气海穴、足三里穴等部位,起到了健脾和

[DOI] 10.19793/j.cnki.1006-6411.2025.36.001

[工作单位] 1.右江民族医学院研究生学院 百色 533000;  
2.广西百色市人民医院 百色 533000

[作者简介] 覃海平,女,硕士研究生,主管护师

[通信作者] 时宗泽

[基金项目] 2022 年百色市科学研究与技术开发课题(项目编号:20222014)

[收稿日期] 2024-09-19

胃、行气消食、辅助抑菌等作用;时燕<sup>[21]</sup>采用穴位贴敷太冲穴、气海穴、关元穴、阴陵泉穴,治疗后患者的抗病能力增强、炎症减轻、生活质量显著提高,这一结果与何锦雄等<sup>[22]</sup>的研究结果一致,均证实该疗法可改善胃肠道功能。

临床中,穴位贴敷可根据 Hp 感染相关性胃炎等不同病情选择相应的药材,实现个性化治疗。常用的药物调方为:干姜 15 g、白芥子 5 g、细辛 5 g、吴茱萸 15 g,研成粉末后加入姜汁调制成膏状<sup>[10,20-24]</sup>;贴敷穴位多选中脘、足三里、神阙、气海、关元、太冲、阴陵泉等,每日 1 次,每次贴敷 2~4 h,贴敷时间需要根据药物的性质和患者的皮肤耐受度调整。穴位敷贴应用于胃肠道相关穴位,能起到强健脏器功能、调节阴阳、强化胃肠道功能的效用,对 Hp 感染防治具有一定的辅助治疗作用。

**2.2 耳穴贴压的应用及效果** 耳穴贴压通过调节气血、平衡阴阳发挥作用。中医理论认为,耳部与脏腑经络有密切的联系,人体脏腑器官及躯体部位均在耳部有对应反射区;以王不留行耳穴贴敷相应穴位,通过刺激局部耳穴、调节气血,达到治疗疾病的目的,其核心遵循耳针理论、中医辨证原则,通过穴位组合调整相应脏腑经络气血功能<sup>[19]</sup>。例如,时燕<sup>[21]</sup>对 Hp 患者采用耳穴贴压疗法(选取交感、神门、皮质下穴及胃、脾耳穴),结果显示:该疗法增强了患者的抗病能力、减少了胃肠道反应并提高了生活质量;李白玉等<sup>[25]</sup>针对 Hp 感染伴胃痛、食欲不振、烧心、反酸等典型胃部不适症状的患者,选取心、脾、胃、肝、神门、皮质下耳穴实施贴压,治疗后患者的 Hp 根除率上升、临床症状评分降低,证实该疗法有效,与周宁<sup>[26]</sup>的研究结论一致(均能提高 Hp 根除率、提升生活质量)。耳穴贴压的常用穴位为皮质下、脾、胃、交感、神门等,可根据患者的不同临床症状增减穴位;护士先对耳部穴位进行消毒,将王不留行贴敷于穴位,叮嘱患者每日按压 1 次(直至出现痛、胀或麻的感觉),两耳交替按压,14 d 为 1 个疗程;密切观察贴压后耳部皮肤情况,若出现红肿、瘙痒等过敏现象,则及时取下贴压物,并给予抗过敏药物处理<sup>[10,23-26]</sup>。耳穴贴压能够达成疏肝理气、驱散郁滞之效,助力调和人体阴阳,促使经络畅达、气血流通无碍,实现脏腑机能的良性调节,应用于 Hp 感染患者,可减轻其身体不适感、提高生活质量。

**2.3 穴位按摩的应用及效果** 穴位按摩是通过特定手法作用于人体体表特定部位或穴位的疗法,具有疏通经络、散寒止痛、健脾和胃、消积导滞、扶正祛邪等作用,可达到预防保健、促进病体康复的目的<sup>[19]</sup>。梅晓杰等<sup>[27]</sup>在 Hp 感染相关性慢性胃炎患者中开展研究,将患者分为中医穴位按摩组和常规护理组,结果显示:

中医穴位按摩组患者的疼痛感减轻、疼痛持续时间缩短、复发率降低,且生活质量提升幅度显著优于常规护理组;张子曼等<sup>[28]</sup>对 Hp 感染患者实施个性化穴位按摩护理,如气虚者多按摩气海、俞穴等穴位,阴虚者按摩足三里、三阴交等穴位,通过按摩疏通经络,可增强其胃肠功能、抗病能力并促进康复,且患者的依从性和满意度较高,这一方法与丁嘉妮等<sup>[9]</sup>的研究方法一致,均证实穴位按摩可提升 Hp 感染患者的生活质量与满意度。按摩选穴常以中脘、脾俞、胃俞、足三里、内关、神阙等穴位为主,以指腹进行按摩,每个穴位按摩 2~5 min,每天按摩 1~2 次,持续 2 个月,按摩力度要适中、均匀、持久、柔和,由轻到重,再由重到轻,根据患者的体质、病情和耐受程度调整<sup>[9,27-29]</sup>。穴位按摩在防治 Hp 感染方面,主要通过活血通络、提升机体免疫力发挥作用,同时能够直接或间接地影响脏腑的生理功能,具有操作简单、安全有效、无药物不良反应等优点。

**2.4 灸法的应用及效果** 灸法是利用某些燃烧材料熏灼或温熨体表的特定部位,借助灸火的热力和药物的作用刺激经络腧穴,以达到温经通络、活血行气、散寒祛湿、消肿散结、回阳救逆及预防保健目的的一种疗法<sup>[19]</sup>。《医学入门》记载:“凡病,药之不及,针之不到,必须灸之。”施灸的材料很多,但以艾叶制成的艾绒为主。因其味苦、辛温无毒,可“主灸百病”,主要适用于慢性虚弱性疾病及风寒湿邪所致病证(如中焦虚寒型呕吐、腹痛、腹泻、脾肾阳虚证等)。马刚等<sup>[30]</sup>对脾胃虚寒型 Hp 阳性慢性萎缩性胃炎患者,采用黄芪建中汤联合募配穴灸法(选穴中脘穴、足三里穴)治疗,结果显示:该方案可提高临床疗效与 Hp 根除率,较常规治疗措施更能改善临床症状、降低炎症水平,且无明显不良反应,治疗安全性较高,值得临床应用;林慧玲<sup>[31]</sup>对脾胃虚寒证 Hp 相关消化性溃疡患者,选取大椎、足三里、胃俞、脾俞、中脘等穴位施灸,结果显示:联合电子灸可有效改善胃脘疼痛、胸胁胀满、纳差等症状,降低中医证候积分、提高证候疗效,减少西药治疗的不良反应率,这一结果与王明华<sup>[32]</sup>的研究一致。

灸法可通过提高局部温度、扩张血管,促使胃黏膜自我调节并修复损伤,对 Hp 感染防治发挥积极作用,也证明了灸法与脏腑经络的理论系统有关<sup>[33]</sup>。常用灸疗穴位为胃俞、脾俞、中脘、足三里等,以局部温热感为宜,每日 1 次,每次 20 min;操作时需控制施灸距离和温度,防止烫伤,同时注意保护患者隐私,注意保暖,避免着凉<sup>[30-32]</sup>。

**2.5 中医特色护理在 Hp 感染防治应用中的总体评价**

中医特色护理认为人体是一个有机的整体,疾病的发生和发展与人体的整体功能失调有关。因此,在护理过程中,中医特色护理注重从整体上评估患者的

健康状况,列出个性化的护理计划,综合运用多种护理手段促进患者的整体康复。在 Hp 感染防治中,穴位贴敷、耳穴贴压、穴位按摩、灸法等经典中医特色护理技术各具优势,整体呈现疗法多样、操作简便、安全副作用少、耗材成本低的特点。例如,耳穴贴压与穴位按摩操作简单、可居家实施、经济负担轻,方便患者持续保健、巩固疗效,提升患者的就医获得感及满意度。

现有研究证实,这些中医特色护理技术可缓解 Hp 感染患者胃部不适、减轻疼痛、提高 Hp 根除率,对 Hp 感染防治具有积极作用,值得在未来研究中进一步推广。

### 3 中医特色护理中的膳食疗法与情志疗法

**3.1 膳食疗法的个性化应用及成效** 中医强调“饮食养生”,认为适当的饮食调理有助于维持人体的平衡。饮食起居被视为 Hp 感染的重要诱因<sup>[34]</sup>,因而在防治 Hp 感染中,中医建议避免辛辣、油腻食物,多食用清淡、容易消化的食物,以减轻对胃黏膜的刺激,促进胃肠道功能的正常运行。合理的饮食结构可以影响胃黏膜的微环境,抑制 Hp 生长。例如,脾胃虚寒者长期适量食用山药、薏苡仁等,可健脾祛湿、温补驱寒;气血不足者食用鱼肉、猪肝有助于增强肝脏功能,同时也能起到补血的效用,如红枣、桂圆则是补血佳品;肝郁气滞者食用玫瑰花、陈皮等中药材,有助于养肝行气、增强机体抗病能力;脾胃湿热者食用藕粉、绿豆汤等,能清热燥湿、凉血止血<sup>[10]</sup>。

相关研究表明,Hp 可在牛奶、新鲜果蔬、新鲜肉类中存活<sup>[35]</sup>,因此建议在中医膳食基础上结合西医饮食治疗方案,指导患者养成良好的饮食习惯,尽量少吃或不生食蔬菜,避免油腻、辛辣、刺激性食物(如腌制食品、油炸食品),可适当食用豆类、蜂胶及大蒜等食物<sup>[36]</sup>。也有研究表明,进食高盐辛辣腌制食品及高脂肪、高糖食物,会在很大程度上增加 Hp 感染风险,但适量食用生蒜及豆制品,可降低 Hp 感染风险<sup>[37-41]</sup>。

在 Hp 感染饮食调护中,中西医结合护理模式更值得推广。Hp 感染管理规范中强调了应养成良好的卫生习惯,如饭前便后洗手、注重口腔卫生、保证生活用水清洁等;提倡聚会就餐时使用“公筷、公勺”并推行“分餐制”,减少口—口传播 Hp 的概率<sup>[1]</sup>。膳食疗法针对 Hp 感染不同证型给予相应的饮食调护,体现的辨证施护与现代护理的个性化护理理念相契合。因此,应充分利用中西医结合护理模式防治 Hp 感染,提高全民健康水平。

**3.2 情志疗法的应用及积极影响** 根据中医学相关理论,人有七情(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊),是人体在各种内外因素刺激作用下表现出的各种情志反应。对健康人群而言,七情在正常范围内不会致病,但若超出

范围,则可能导致脏腑气血功能紊乱,进而引发疾病。情志护理正是基于七情理论,在做好沟通工作的同时,运用科学的护理方法对患者进行护理,以缓解其负面情绪、预防疾病进展<sup>[19]</sup>。

近年来的研究表明,焦虑及抑郁情绪会增加 Hp 感染风险<sup>[42]</sup>,且 Hp 感染患者常伴有不良心理状态,容易受外界环境及心理因素的影响<sup>[43-44]</sup>。而良好的心理状态及健康生活方式是防治 Hp 的重要措施之一<sup>[7]</sup>。因此,在情志疗法中,针对 Hp 感染患者的主要核心为:引导患者保持心情舒畅,日常生活中尽量减少生气,自我调节心态;帮助患者认识到保持健康积极心态的重要性,避免焦虑、恐慌,鼓励其保持平和、开朗的心态,树立战胜疾病的信心<sup>[21]</sup>。

五行音乐疗法是情志疗法中的一种,其核心逻辑为“五音属五行、应五脏、动五志”,与脏腑的生理特性相互照应<sup>[45]</sup>。治疗时,将五音(角、徵、宫、商、羽)与五脏(心、肝、脾、肺、肾)相对应,根据患者的病变所属,通过对应的音乐进行干预,从而改善其身心状况<sup>[46]</sup>。薛静等<sup>[47]</sup>在癌症化疗患者中开展音乐疗法研究,结果发现:干预后患者恶心、呕吐等常见副反应明显缓解,生活质量和化疗依从性大幅提高;张华建等<sup>[48]</sup>探讨五行音乐宫调在胃癌患者中的应用效果,得出“宫调有利于改善胃癌患者生活质量及预后”的结论。

现代医学研究发现,五行音乐疗法的原理是五脏都有各自的振动频率,而这些频率和五行音乐存在对应关系;五行音乐释放的能量对体内气血有一定的调节作用,从而实现治疗的目的<sup>[49]</sup>。应用五行音乐疗法需要注意患者体质、年龄、疾病状态的差异,结合其情绪状态精准对应。例如,阳虚体质者阳气不足,可能对属火的徵音更敏感,聆听时要注意控制时间和音量,因为徵音有振奋阳气的作用,过度聆听可能会导致阳气过亢,引发口干舌燥、心烦等“上火”症状。

中医情志疗法与西医心理疗法理念相通,均强调通过心理干预调节身心状态。当患者出现悲伤、焦虑、失眠、抑郁等症状时,及时给予心理疏导及有效沟通,可排解不良情绪、引导健康的生活行为方式。其中,五行音乐疗法是中医独特的情志疗法之一,认为五音与五脏有着密切的联系,如“心主神明,徵音(属火)养心安神”。对于伴有沮丧、悲伤、睡眠质量差等的 Hp 感染患者,可根据具体症状选择相应的五行音乐,通过调畅情志、调节脏腑机能、改善睡眠质量,为疾病治疗提供辅助。

## 4 小结

中医特色护理在 Hp 感染防治中已取得积极的成果。相应的中医护理技术有穴位贴敷、耳穴贴压、穴位

按摩、灸法等,可通过调节气血、平衡阴阳、调畅气机、改善微循环,为 Hp 感染治疗创造有利条件;在临床症状改善方面,这些中医特色护理技术能有效缓解腹胀、胃脘痛、反酸、嗝气等症状,同时提高 Hp 根除率及患者的生活质量。此外,膳食疗法及五行音乐疗法也是 Hp 感染患者进行身体机能调节、改善心理状态、促进身体康复重要的中医护理方法。

未来在防治 Hp 感染领域,可以开展大规模中医特色护理临床研究,验证中医特色护理在不同人群、不同病情阶段的有效性和安全性,还可以结合现代科技手段,如大数据分析、人工智能等,为中医特色护理的应用提供更科学的依据,并制定更具个性化的干预方案。

#### 参 考 文 献

- [1] 胡奕,祝荫.幽门螺杆菌感染治疗的规范化管理[J].中国实用内科杂志,2023,43(4):292-295.
- [2] 朱红梅,刘颖初,薛元,等.2012—2022 年中国幽门螺杆菌流行病学 Meta 分析[J].预防医学情报杂志,2023,39(9):1124-1137.
- [3] ZHOU X Z,LYU N H,ZHU H Y,et al.Large-scale,national,family-based epidemiological study on *Helicobacter pylori* infection in China;the time to change practice for related disease prevention [J].Gut,2023,72(5):855-869.
- [4] 林垵皓.幽门螺杆菌根除治疗失败的危险因素分析及风险预测模型的构建[D].广州:南方医科大学,2023.
- [5] Schistosomes,liver flukes and *Helicobacter pylori*[J].IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans,1994,61:1-241.
- [6] 李贤莉,易平,严群,等.中医辨证施护对幽门螺杆菌感染消化性溃疡患者的干预效果分析[J].时珍国医国药,2022,33(9):2192-2194.
- [7] 易惺钱.基于扶正祛邪理论的中医药治疗幽门螺杆菌感染相关疾病的证治规律研究[D].南昌:江西中医药大学,2021.
- [8] 曾会萍,曾美男.中医综合护理干预辅助治疗幽门螺杆菌相关性胃炎疗效观察[J].中西医结合护理(中英文),2017,3(2):58-60.
- [9] 丁嘉妮,胡峰,郁培,等.中医特色护理对幽门螺杆菌相关性胃炎的护理效果[J].中外医疗,2023,42(35):143-146.
- [10] 王畅,鲁丹,唐雪梅.中医护理对幽门螺杆菌相关性胃炎患者的干预效果[J].当代护士(中旬刊),2019,26(2):98-100.
- [11] 唐春华,赵晓瑞,胡可芹.幽门螺杆菌感染病人健康教育的研究进展[J].全科护理,2022,20(33):4630-4633.
- [12] 吴佳栩.幽门螺杆菌感染患者症状特征与中医体质相关性研究[D].北京:北京中医药大学,2021.
- [13] 李京尧,王盼,刘文静,等.幽门螺杆菌相关性胃炎患者中医体质与中医证型相关性研究[J].时珍国医国药,2020,31(10):2416-2418.
- [14] 胡伏莲,张声生.全国中西医整合治疗幽门螺杆菌相关“病—证”共识[J].中国中西医结合消化杂志,2018,26(9):715-723.
- [15] 张弘,何凌.幽门螺旋杆菌感染中医病因探讨[J].辽宁中医药大学学报,2018,20(1):190-192.
- [16] 刘斌斌,胡运莲,林敏,等.幽门螺杆菌感染与中医“湿热生虫”关系的研究[J].中国中医基础医学杂志,2019,25(8):1094-1096.
- [17] 陈署洪,吕冠华.中西医治疗幽门螺杆菌感染研究进展[J].中外医学研究,2023,21(5):175-180.
- [18] 游佳琪.幽门螺杆菌感染的中医体质分布及相关危险因素分析[D].哈尔滨:黑龙江中医药大学,2022.
- [19] 孙秋华.中医护理学[M].5版.北京:人民卫生出版社,2022:141.
- [20] 刘萍,瞿凡,徐阳,等.中药穴位贴敷联合三联疗法治疗幽门螺杆菌感染疗效观察[J].山西中医,2023,39(5):48-49.
- [21] 时燕.中医干预对 *H.pylori* 感染致胃痛患者的疗效[J].河北医药,2022,44(15):2340-2342,2346.
- [22] 何锦雄,张凤敏.中药穴位贴敷疗法治疗脾胃虚寒型慢性胃炎的临床观察[J].实用中西医结合临床,2022,22(19):18-21.
- [23] 陈艳美,王梅.中医护理对幽门螺杆菌相关性胃炎患者的干预效果[J].世界最新医学信息文摘,2020,20(100):304-305.
- [24] 邓娟娟,邓琼琪,罗尧岳.穴位敷贴联合三联疗法对脾胃虚弱型 Hp 相关性胃病的护理效果观察[J].湖南中医杂志,2021,37(6):94-96,177.
- [25] 李白玉,周伟.针刺联合耳穴贴压治疗幽门螺杆菌感染胃炎 30 例[J].中国针灸,2021,41(9):991-992.
- [26] 周宁.耳穴贴压对十二指肠球部溃疡患者胃泌素、幽门螺杆菌及生活质量的影响[D].福州:福建中医药大学,2012.
- [27] 梅晓杰,钟阳.穴位按摩在幽门螺杆菌感染慢性胃炎中的应用效果[J].光明中医,2020,35(11):1690-1692.
- [28] 张子曼,李睿钧,张曼兰,等.基于循证理论的中西医结合路径化干预对牙周炎幽门螺杆菌感染病人的影响[J].全科护理,2020,18(35):4935-4937.
- [29] 卜海珠,胡华娟,腾惠兰,等.穴位按摩对幽门螺杆菌感染慢性胃炎的护理疗效观察[J].现代诊断与治疗,2016,27(23):4582-4584.
- [30] 马刚,张西青,马璨,等.黄芪建中汤联合募配穴灸法辅助治疗脾胃虚寒型幽门螺杆菌阳性慢性萎缩性胃炎的疗效观察[J].中华养生保健,2024,42(15):16-19.
- [31] 林慧玲.电子灸联合四联疗法治疗 Hp 相关消化性溃疡(脾胃虚寒证)的临床研究[D].福州:福建中医药大学,2020.
- [32] 王明华.隔附子饼灸结合西药治疗虚寒型消化性溃疡的临床研究[D].广州:广州中医药大学,2018.
- [33] 蒋志惠,常雪梅,张照然,等.艾草的化学成分和药理作用研究进展[J].中国兽药杂志,2019,53(2):76-85.
- [34] 张万岱,胡伏莲,萧树东,等.中国自然人群幽门螺杆菌感染的流行病学调查[J].现代消化及介入诊疗,2010,15(5):265-270.
- [35] ZAMANI M,VAHEDI A,MAGHDURI Z,et al.Role of food in environmental transmission of *Helicobacter pylori*[J].Caspian Journal of Internal Medicine,2017,8(3):146-152.
- [36] 林华琴,黄美娜,李碧真.自我行为与饮食护理干预对幽门螺杆菌感染患者自我效能与预后的影响[J].吉林医学,2023,44(7):2003-2005.
- [37] 徐丽琴,杨齐华,顾君娣,等.学龄前儿童幽门螺杆菌感染状况及其影响因素调查分析[J].中国妇幼保健,2020,35(7):1316-1318.
- [38] 张明伟,汪建超,王启之,等.安徽中南部地区幽门螺杆菌流行病学调查[J].中华全科医学,2020,18(8):1395-1398.
- [39] SHU L,ZHENG P F,ZHANG X Y,et al.Dietary patterns and *Helicobacter pylori* infection in a group of Chinese adults ages between 45 and 59 years old;an observational study[J].Medicine,2019,98(2):e14113.

## [ 文献研究 ]

本科实习护生及低年资护士临床决策能力的现状  
和影响因素的研究进展

赵婉辰

【摘 要】 高水平的临床决策能力不仅体现护理学科的逻辑性和专业性,更是患者安全与健康的重要保证。本科实习护生和低年资护士是未来护理工作的核心力量,临床决策能力直接影响前者的实习质量与后者的工作质量。因此,现对本科实习护生及低年资护士临床决策能力的测评工具、现状及影响因素进行综述,分析当前研究的局限性,指明未来的研究路径,以期为临床教学活动中进一步提升二者的临床决策能力提供参考。

【关键词】 本科实习护生;低年资护士;临床决策能力;影响因素

在护理实践中,正确的临床决策可为护理工作的顺利开展打下坚实的基础。临床决策是医护人员在工作过程中结合理论知识和临床经验,运用评判性思维获取并评估患者的信息,并在循证的基础上采取行动方案的连续过程<sup>[1-2]</sup>。研究表明,高水平的临床决策能力可以提升护理干预的科学性、有效性,进而显著降低护理操作差错和不良事件的发生风险,综合改善患者的临床结局并保障其安全<sup>[3-4]</sup>。因此,临床决策能力的培养是护理教育者与管理者应重点关注的环节。

本科实习护生是未来护理工作的主要力量。然而,其前三年均在学校进行理论知识学习,最后一年才充分接触临床护理工作,正处于理论和实践的过渡期,尚不能有效地将理论与实践结合。因此,面对复杂多

变的病情时,他们往往感到困惑和不知所措,难以依据既定的护理目标为患者制订充分符合其自身情况的护理计划,并从中决断、付诸实施。而较高水平的临床决策能力,可帮助本科实习护生有效减少不确定感,增强自我效能感<sup>[5]</sup>,进而在面对复杂临床现象、情境或问题时,能够基于逻辑推理进行合理判断与决策。

低年资护士是临床护理工作的青年骨干力量。但由于临床工作经验不足,相较于高年资护士,他们往往更容易发生护理差错;而通过有效评估、及时给出正确的临床决策,可以有效避免护理差错发生<sup>[6]</sup>。

本科实习护生和低年资护士虽在临床工作的时间长短上有所不同,但均处于临床护理工作的起步阶段。既往研究也表明,这两类人群的临床决策能力均处于中下等水平<sup>[6-7]</sup>。因此,关注这两类人群临床决策能力的现状及影响因素具有重要的意义。本文通过总结本科实习护生及低年资护士临床决策能力的现状及影响因素,旨在为临床教学实践提升其临床决策能力提供建议。

【DOI】 10.19793/j.cnki.1006-6411.2025.36.002

【工作单位】 北京协和医院护理部 北京 100730

【作者简介】 赵婉辰,女,硕士研究生在读,护士

【收稿日期】 2024-09-29

\*\*\*\*\*

[40] 王文玲,宋晓梅,赵玲.幽门螺杆菌感染的危险因素及相关护理干预对策研究[J].国际医药卫生导报,2020,26(8):1161-1164.

[41] 吴寒寒,王陈,汪光军,等.安徽省某胃癌高发县40~69岁居民食盐及腌渍食物摄入与幽门螺杆菌感染状况的调查与分析[J].中华疾病控制杂志,2020,24(2):164-169.

[42] 鲁钰,方向明.有消化道症状者幽门螺杆菌感染与焦虑抑郁状态的相关性[J].武警后勤学院学报(医学版),2021,30(4):22-26.

[43] ALHALABI M, ALASSI M W, ALAA EDDIN K, et al. Efficacy of two-week therapy with doxycycline-based quadruple regimen versus levofloxacin concomitant regimen for helicobacter pylori infection: a prospective single-center randomized controlled trial[J]. BMC Infectious Diseases, 2021, 21(1): 642.

[44] 徐婷婷.临床护理路径对消化性溃疡患者幽门螺杆菌根除率、心理情绪及遵医行为的影响[J].河南医学研究,2020,29(31):

5936-5938.

[45] 高昭,曾静,吕品,等.中医五音疗法干预气虚质人群临床观察[J].河北中医,2024,46(7):1065-1069,1073.

[46] 吕俭霞,高静,苟朝琴,等.五行音乐疗法改善肿瘤病人生存质量及负性情绪研究的方法学及报告质量评价[J].循证护理,2018,4(2):117-123.

[47] 薛静,张丽燕,杨琪.音乐治疗缓解癌症患者化疗后恶心呕吐改善生活质量的研究[J].护理学报,2017,24(1):70-72.

[48] 张华建,肖红,呼佳,等.五行音乐宫调配合穴位按摩在胃癌晚期病人安宁疗护中的应用[J].护理研究,2020,34(24):4379-4383.

[49] 张荣荣,顾丽雅,庄建红.中医五行音乐结合语言诱导对维持性血液透析患者生活质量和精神状态的影响[J].新中医,2019,51(11):267-270.

【本文编辑:曹思军】